

MOTIF DE CONSULTATION

Baisse subjective de l'audition à l'oreille droite qui aurait été plutôt soudaine il y a environ 6 semaines. Monsieur rapporte une histoire d'otites à répétition dans l'enfance. Depuis environ 20 ans, il aurait des vomissements accompagnés de vertiges 2 à 3 fois par année. Il aurait également des vertiges lorsqu'il se lève. Difficultés de compréhension de la parole en présence de bruit et en groupe. Monsieur rapporte avec un méningiome au cerveau depuis quelques années et un suivi médical environ au 18 mois. Histoires otologique, personnelle et familiale par ailleurs sans particularité. Anamnèse complète effectuée.

RÉSULTATS AUDIOLOGIQUE

Otoscopie : Aucune particularité pouvant empêcher la réalisation des épreuves.

Épreuves tonales et vocales :

Oreille droite : Hypoacousie neurosensorielle descendante de très légère à modérément sévère de 1000 Hz à 8000 Hz. L'audition est dans les limites de la normale à 250 et 500 Hz. Excellente identification de la parole (monosyllabes) au niveau confortable (92% à 65 dBHL).

Oreille gauche : Hypoacousie neurosensorielle descendante de très légère à modérément sévère de 250Hz à 8kHz. Très bonne identification de la parole (monosyllabes) au niveau confortable (88% à 65 dBHL).

Épreuves impédancémétriques :

Oreille droite : Impossible d'obtenir l'étanchéité.

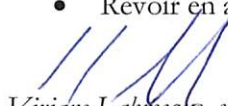
Oreille gauche : Bonne mobilité tympanique et présence des réflexes stapédiens en stimulation ipsilatérale et globalement en stimulation contralatérale.

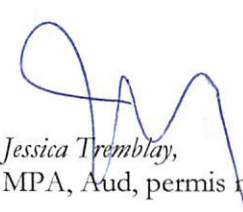
CONCLUSION AUDIOLOGIQUE

Les résultats montrent une atteinte auditive neurosensorielle de très légère à modérément sévère en moyenne et hautes fréquences aux deux oreilles. Les résultats sont compatibles avec la presbyacousie. Les résultats ne nous permettent pas d'expliquer la perception subjective d'asymétrie en défaveur de l'oreille droite. L'atteinte auditive est suffisamment importante pour causer des difficultés de compréhension de la parole, notamment en présence de bruit. Un appareillage auditif bilatéral aiderait à mieux entendre.

INTERVENTIONS - RECOMMANDATIONS - PLAN DE TRAITEMENT

- Les résultats ont été expliqués en lien avec les impacts d'une surdité sur la communication. Discussion concernant l'appareillage auditif (avantages, limites, habitude) et sur les avantages d'un appareillage bilatéral (ex : maximiser l'écoute binaural).
- Suite à l'évaluation globale des besoins, **recommandons un appareillage auditif bilatéral.**
 - **Le patient n'est pas éligible au programme RAMQ pour le moment.**
- Revoir le médecin ORL.
- Revoir en audiologie dans 1 an.


Viviane Labrecque, stagiaire, no.3657s
audiologiste Étudiante à la maîtrise en audiologie
Université de Montréal


Jessica Tremblay,
MPA, Aud, permis no. 2591

p.j. audiogramme
c.c. patient

Cliniques en santé auditive et communication

Un seul appel, on s'occupe de vous: 1 866 411-5623 | www.lobe.ca

Rédaction : 2017-02-28

Lobe

1575 l'Avenir, bureau 120, Laval, H7S 2N5 Tél.: 450 934-2614 Téléc.: 450 934-2615